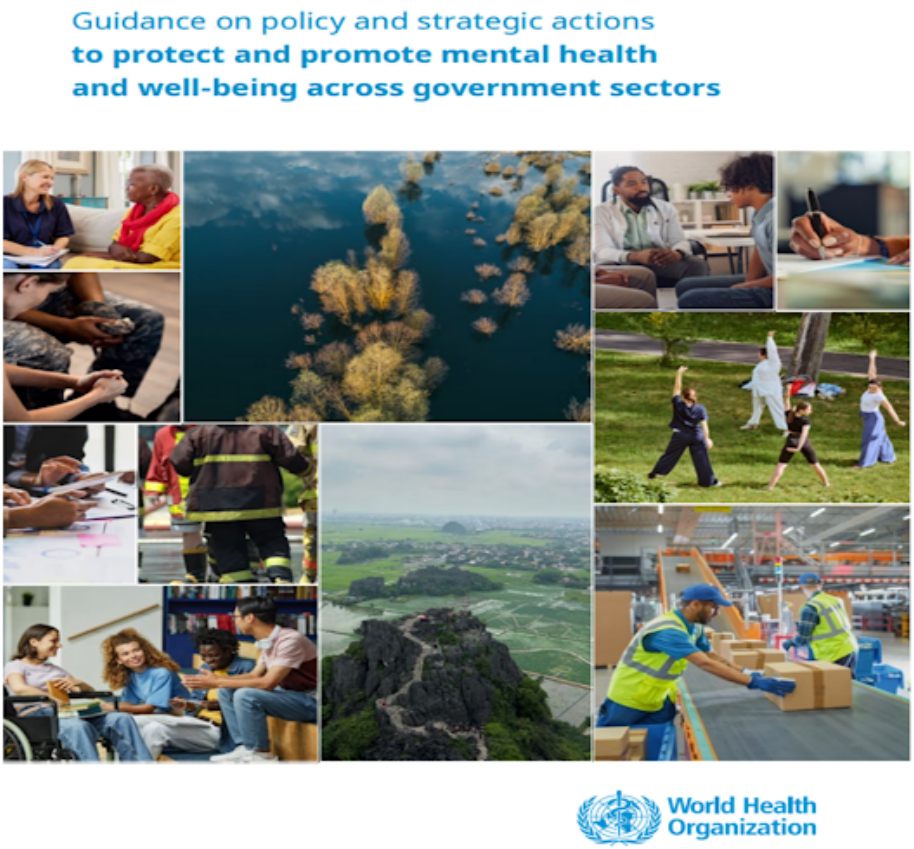
心理健康融入所有政策 世界衛生組織 WHO　最新指導方針

(臺灣心理健康聯盟提供　心理健康城市論壇 參考資料 02/25576980)

MHiAP 的 WHO 全新指導方針



2025 年11 月，**世界衛生組織**(WHO)發布新的《保護及促進政府各部門心理健康與幸福的政策與策略行動指引》(Guidance on policy and strategic actions to protect and promote mental health and well-being across government sectors)，旨在透過各政府部門採取行動，保護及促進心理健康，這是朝向「**心理健康融入所有政策**」(MHiAP)方針邁出的重要一步(WHO, 2025)。

保護及促進心理健康，需要各部門採取"協調一致"的行動。這份新指引首次明確說明，不同政府部門可以如何各自及共同採取行動，以促進及保護**全體人口**的「**心理健康**」與「**幸福**」。這份新的跨部門指引，是 **WHO** 在 **2025 年** 3 月稍早發布的《心理健康政策與策略行動計畫指引》(Guidance on Mental Health Policy and Strategic Action Plans)基礎上進一步發展而成。前者界定了建立**以「人權」為基礎**、**具良好品質的心理健康體系與服務**所需的基本要素；而

新的部門指引則將關注範圍***擴大至「心理健康」部門以外***，為政府各部會及機關提供明確方向，協助將「**心理健康**」考量融入其核心政策、策略與計畫之中(WHO, 2025)。

本出版品除了提供如何建立高層級跨部門「**心理健康**」倡議的指引，也針對以下 **11 個關鍵部門**，提出保護及促進「**心理健康**」與「**幸福**」的相關建議(WHO, 2025)：

- 財政與國庫(發揮跨政府的整體協調作用)
- 文化、藝術與體育
- 國防與退伍軍人事務
- 教育
- 就業
- 環境、保育與氣候保護
- 衛生
- 內政
- 司法
- 社會保障
- 城鄉發展

各部門的指引均列出關鍵**政策方針**、**策略行**動，以及可用於衡量進展的示例指標，協助各國依據自身的國家與地方脈絡調整政策執行方式。

這份指引以**人權**、公平與**實證**為基礎，強調不採取行動所造成的成本，以及***投資心理健康所能帶來的社會效益***。指引呼籲採取「**全政府**」(whole-of-government)與「**全社會**」(whole-of-society)的整體性做法，串聯各部門的高階領導者及其他相關行動者與推動力量，促進跨部門合作，並確保「**心理健康政策**」具有**責信**(accountability)機制及永續的資金支持(WHO, 2025)。

此外，指引也提供一份行動路線圖，協助各國政府將承諾轉化為實際行動。路線圖提出**八項實務步驟**，從**啟動高層級對話**、**檢視現有政策**，到**執行**、**監測**及**評估**進展，協助所有政府部門如何將「**心理健康**」與「**幸福**」納入各部

門相關政策中，並持續推動能夠促進全民「**心理健康**」與「**幸福**」的政策(WHO, 2025)。

一、以全政府方式推進心理健康與幸福



鑑於「**心理健康**」與「**幸福**」與結構性及「**社會決定因素**」，以及《**永續發展目標**》(SDGs)*彼此相互關聯*，因此需要透過「**全政府**」及「**全社會**」的方式進行跨部門合作，才能採取全面且協調一致的因應措施。許多國家可能已在*衛生部門以外*的領域採取相關措施。然而，此新指引所關注的是如何在各部門之間整合「心理健康」行動。針對「**心理健康**」部門本身的建議政策、策略與行動，已在《心理健康政策與策略行動計畫指引》的第 1 至第 5 項議題中進行更全面的討論。

當然，*「心理健康」絕不只是「衛生」議題*：它涵蓋從國家層級到地方

政府的多個部門，包括一般健康照護、教育、就業、城鄉發展、社會保障、司法、文化、藝術、體育、國防與退伍軍人事務、環境、保育與氣候保護，以及內政。

因此，所有政府部門都必須共同努力，將「**心理健康**」與「**幸福**」納入各項政策、策略與計畫之中，*從根本上處理結構性及「社會決定因素」*。尤其是，**財政與國庫部門**必須將公平性與「**幸福**」置於決策核心，無論是在**制定稅率**，或是在**分配社會福利與補助資源**時皆然。這是因為，*將「心理健康」納入各項政策與實務之中*，有助於各政府部門落實本指引所提出的政策方針與策略行動，*不僅能提升社會整體的「幸福」與永續性*，*也能協助各國實現其發展目標與指標*。

二、全政府方式的發展、執行與評估

(一)跨領域共同原則

在規劃以「**全政府**」方式推進「**心理健康**」與「**幸福**」，或制定特定部門的相關政策時，遵循以下幾項跨領域共同原則，可以提供重要的方向。雖然具體的指導原則可能會因**社會**、**文化**及**經濟**脈絡而有所不同，但常見的跨領域原則包括：

1.採取以人權為基礎的方法

這是指建立並實施以**國際人權法**為基礎的架構，以促進及保障**人權**。這包括採取法律與政策框架，使國家能夠履行其國際法下的義務。這種方法能協助國家及非國家行動者辨識、分析並處理**不平等**與**歧視**問題，並接觸及支持**遭受邊緣化的人群**。同時，也能為必要的補救措施與「**責信**」機制提供途徑。

2.採取生命歷程(life-course)方法

此原則考量個人在**各個年齡階段**的經驗與影響因素，並認識到**早期生命經驗**、**社會環境**及**人生轉變**會對長期結果產生深遠影響。這種方法認為，*人生各階段彼此相互連結*。發生在某一人生階段的事件或情況，可能影響個人在**教育**、**就業**、**人際關係**及「**心理健康**」等不同領域未來的發展與「**幸福**」。「**生命歷程**」方法旨在制定政策與介入措施，以支持個人在重要人生轉換階段的需要，並促進社會的長期進步。

3.回應心理健康的結構性與社會決定因素

「**結構性決定因素**」涵蓋**社會經濟**與**政治環境**。這些因素形塑「**權力**」與**資源**如何**被分配**，也影響**社會階層**(social stratification)，進而對人口健康產生深遠影響。「**社會決定因素**」則是人們出生、成長、生活、工作及老化時所處的各種**環境**與**條件**。這些因素都會影響「**心理健康**」，包括但不限於：

- 社會階級與社會地位
- 污名與歧視
- 貧窮
- 失業或教育程度較低
- 就業或工作不穩定
- 無家可歸或居住不穩定
- 糧食不安全
- 健康緊急事件
- 氣候變遷
- 自然災害
- 污染及工業災害
- 人道危機與被迫遷移
- 弱勢移民處境
- 暴力與虐待
- 孤獨與社會孤立

4.確保具有實質意義的參與，納入具親身經驗者的聲音

無論是曾經歷「**心理健康**」問題、接受「**心理健康**」服務，或曾因「**心理健康**」問題而面臨歧視風險與被排斥的人，**具親身經驗者**(people with lived experience)都能深入了解關鍵挑戰，並提出具體且符合脈絡的改善建議。讓這些人參與政策與決策，有助於確保所提出的解決方案能真正回應受影響者的需求。

5.消除污名與歧視，並改變對心理健康的思維與文化

這需要積極減少與「**心理健康**」問題或「**心理社會障礙**」相關的**負面刻板印象**、**錯誤觀念與偏見**。同時，也**需要改變政府各部門的態度**，***使「心理健康」受到優先重視***，並整合至所有政策、策略及計畫之中。這種轉變的目標，是***確保「心理健康」被視為跨政府各部門共同承擔的責任***。

6.採取以實證為基礎的方法

各部門的政策改革或政策發展，應以**科學實證**及/或**良好實務**作為依據，同時將**成本**、「**成本–功效**」(cost-effectiveness)及**文化因素**納入考量。

(二)政策制定、執行與評估的必要條件

要有效地將「**心理健康**」整合至***各部門***的**政策**、**策略**與**計畫**中，需要具備強大的「**政治意願**」、廣泛的「**利害關係人**」參與、充足的「**財務資源**」，以及明確的「**責信機制**」。這包括以下幾項基礎性要求：

1.政治意願(Political will)

持續的「政治意願」，是發展及有效執行「全政府」方式或各部門具體行動的關鍵。政策文件應透過清楚且**以行動為導**向的語言，展現高度承諾(例如使用「**將(will)**」而非「應(should)」)。有必要取得**高層級**的**政治支持與承諾**。至少，負責該部門的「**部長**」必須支持並認可這項方法。對於需要長期投資、協調與「**責信**」的**高層級跨部門倡議**，「**政治意願**」應延伸至**政府最高領導階層**。建立**定期回報進展**的機制，有助於維持**政策推動**的**動能**與**能見度**。一項具備**政府最高層級回報機制的高層級倡議範例**，是**愛爾蘭**的《國家心理健康促進計畫》(National Mental Health Promotion Plan)。

2.利害關係人參與(Stakeholder engagement)

廣泛的「**利害關係人**」(*主要行動者與組織)認同與支持，對政策成功至關重要。這需要「**利害關係人**」在政策的制定、執行與評估各階段積極參與。尤其應重視讓受議題影響、具有**親身經驗**(lived experience)的人參與，包括曾有「**心理健康**」問題或「**心理社會障礙**」的人，以及**面臨歧視風險**的群體。***「利害關係人」的參與，是確保政策、策略與計畫能夠因地制宜，並反映該地區或國家的社會、文化與經濟情況的重要條件***。

(1)關鍵行動者：

- 各部門的政策制定者及管理人員；

- 政治人物(例如部長、市長及鄉鎮長)；
- 曾親身經歷所討論議題的人，包括具有心理健康問題及心社會障礙親身經驗者，以及遭受歧視之群體的代表；
- 受影響的社群；
- 社區領袖及把關者，例如地方首長或村長、傳統及宗教領袖或治療者；
- 心理健康及一般醫療專業人員，以及各層級醫療照護體系中的其他相關及協同專業人員；
- 家庭成員及其他照顧者；
- 法律及人權領域的專家與專業人員；
- 學術界及研究人員；以及
- 慈善捐助者。

(2)關鍵團體及組織：

- 相關政府部門/機關；
- 身心障礙者組織；
- 具有親身經驗者的組織；
- 其他代表遭受歧視群體的組織；
- 地方公民社會團體；
- 非政府組織(NGO)；
- 慈善及志願服務組織；
- 宗教組織；
- 代表心理健康專業人員、一般醫療專業人員及其他多專業從業人員的組織；
- 代表家庭及照顧者的組織；
- 學術及研究機構；以及
- 法律援助及人權組織。

3.財務資源(Financial resources)

為推進「**心理健康**」而對政策方針與策略行動進行**成本估算**，對於***爭取必要的預算至關重要***。**資源不足**可能使參與執行工作的「**利害關係人**」失去動力，並阻礙預期成果的實現。相較之下，目標較為務實、政策或策略較不具野心但擁有充足資金支持，可能比資金不足的高遠目標帶來更高的承諾，也可能是**更有效運用資源**的方式。為提高政策成功執行的可能性，***應在政策制定過程中同步規劃預算***。

4.責信機制(Accountability mechanisms)

政策及其相關策略及/或計畫，應包含明確的執行機制、時程與可衡量的目標。應仔細考量各「**利害關係人**」群體的角色與責任，並予以清楚界定，同時認識到不同「利害關係人」可能最適合負責執行特定的策略與行動。除了設定目標之外，政策也需要建立機制，以監測及報告政策的執行、產出與成果。產生並運用可靠且最新的資料，有助於辨識需求、追蹤進展，並確保政策能夠回應現實世界中的各項挑戰。這些措施有助於強化「**責信**」，同時也能協助辨識並處理執行過程中的障礙。

(三)八個流程步驟

建立一個**全面**、**具包容性**、**以實證與權利為基礎**的***政策制定、執行與評估流程至關重要***。根據上述所討論的要求，可歸納出「**八個流程步驟**」。這些步驟具有**彈性**，可以**重新排序**。某些步驟可能需要定期重新檢視與更新，例如當情況發生變化，或在政策草擬過程中發現缺口時。以下將說明這些步驟。

各國的起點會有所不同，因此每個國家(以及每個部門)都應先**評估目前已完成哪些工作**。例如，如果某些部門已經正在進行或已完成情勢分析，則可能只需檢視該分析是否具相關性，並處理其中的缺口。

然而，必須認識到，許多政策、策略與計畫之所以未能落實或成效不彰，可能是由於**「政治意願」不足**、**「利害關係人」參與及共識不足**、**對政策指引的認識與理解有限**、**「資金規劃」不切實際**，以及**低估「社會與結構性決定因素」對「心理健康」的影響**。理解這些因素，可以協助規劃者與執行者預先辨識並克服常見的陷阱與障礙。

(I)進行高層次政策對話，在各部門內建立保護與促進心理健康及幸福的承諾與參與

有必要讓高階領導者及工作人員了解保護與促進「心理健康」的效益。各部門需要制定符合自身情況的政策，並配合相關策略及/或計畫。制定各部門的「心理健康」立場文件至關重要。每份文件都應以簡潔、以實證為基礎的分析為核心。可以結合國際研究證據與當地資料，建立支持各部門投資的論據。*一個良好的起點，是繪製某一部門中的關鍵「社會與結構性決定因素」，辨識其中的「風險因素」與「保護因素」*。接著提出明確且可執行的政策建議，以降低風險並促進「**幸福**」。每項建議都可以說明其直接效益。例如，在**教育部門**中，將「**社會情緒學習**」(SEL)納入課程並培訓教師，可以降低學生輟學率、建立「**韌性**」並預防自殺。也應辨識跨部門的共同效益。例如，透過**教育部門**更有效地支持「**心理健康**」，可以改善就業前景、強化社區健康，並可能減輕未來司法體系的負擔。本《**指引**》提供了各部門分析可參考的證據與建議。

(II)提高認識並轉變思維模式，將心理健康納入各部門的政策、策略與計畫

鼓勵每個部門與心理健康部門合作，制定提升認識的策略。這些策略應致力於轉變思維模式、增進對「**心理健康**」的理解，並對抗部門工作人員及領導階層中的污名與歧視。納入具有「**心理健康**」問題及「**心理社會障礙**」親身經驗者的代表，以及其他遭受歧視群體的代表，對於建立具包容性且以充分資訊為基礎的方法至關重要。

(III)檢視現有的部門政策、策略與計畫

每個部門都應成立「**工作小組**」，由該部門的政策專家、心理健康專家以及公民社會代表組成，包括曾親身經歷相關議題的人員。「**工作小組**」應檢視現有的部門政策與相關策略及/或計畫。「**工作小組**」應仔細檢視目前如何處理「**心理健康**」與「**幸福**」，確認哪些部分已獲得充分涵蓋、找出缺口、提出可以加強之處，並標示現行政策或措施中可能對「**心理健康**」造成傷害的地方。此《**指引**》所列的政策指令與策略行動清單，可協助完成此流程。這項檢視的結果應記錄於各部門的情勢分析中。

(IV)建立起草團隊，將心理健康納入部門特定的政策、策略與計畫

「**起草團隊**」應包括來自該部門的「**利害關係人**」、「**心理健康**」部門的「**利害關係人**」，以及其他相關部門的代表；同時也應納入具有「**心理健康**」問題及「**心理社會障礙**」親身經驗者的組織代表，以及其他遭受歧視群體的代表。曾直接經歷相關議題的人員應積極參與。他們可以提供寶貴的第一手見解。例如，在討論司法體系中的「**心理健康**」議題時，應讓曾被監禁的人員參

與其中，並納入其觀點。

(V)修訂或起草政策、策略與計畫，以保護及促進心理健康

根據【**第 III 步驟**】的情勢分析結果進行修訂。此《**指引**》可以提供一系列方案，供各方選擇並調整，以符合自身脈絡。確保「**政策變革**」同時具備累進性(progressive)與可持續性(sustainable)。

(VI)與利害關係人團體及大眾進行更廣泛的諮詢

與「**利害關係人**」團體及大眾進行「**諮詢**」(Consultations)，可以產生回饋，提供機會回應建議、疑慮與反對意見，並據此進一步完善政策。討論也能提高公眾意識，有助於確保最終成果具包容性，並獲得廣泛支持。

(VII)執行政策及相關策略及/或計畫

「**政策改革**」通常涉及多個面向，因此需要調整行政流程與法規，包括制定文件及相關法規。培訓對於協助「**利害關係人**」了解所需採取的行動至關重要，包括教育領導者、管理者及其他關鍵人員，使其了解改革的原因與具體內容。鼓勵各部門制定具體的工作計畫，說明應執行的政策指令與策略行動，包括成功指標、預算、目標及時程。

(VIII)監測與評估執行成效

建立追蹤進度的機制，有助於找出挑戰並進行必要的調整。定期監測與評估可以確保政策改革持續有效，並能因應不斷變化的需求。定期報告，包括呈現指標、成果與障礙，有助於促進「**責信**」，並為持續調整提供依據。例如，可能需要重新分配或調動資源。

此《**指引**》提供了各部門的重要「**心理健康**」指標範例，並將其與策略行動連結。至於更一般性的健康與公平指標，供政府部門參考，請參閱《健康公平社會決定因素監測的行動框架》(Operational framework for monitoring social determinants of health equity)中的表 3。

三、十個關鍵部門相關保護及促進「心理健康」與「幸福」的建議

(一)衛生

各國的「衛生」部門通常負責制定與推動「心理健康」相關的政策與行動。「**心理健康**」與「**身體健康**」密切相關，而「**衛生**」政策提供了許多同時處理

兩者的機會。

例如，具有「**心理健康**」問題或「**心理社會障礙**」的人，**罹患「*身體健康*」疾病的風險較高**，例如糖尿病、心血管疾病、癌症及 HIV/AIDS。這是受到多種因素影響，例如**精神科藥物的作用**、**生活型態因素(例如高吸菸率)**、**居住環境**及**歧視**等。他們的「**全因死亡率**」約為一般人口的***2 至 3 倍***。反過來，許多被診斷出患有「**身體健康**」疾病的人，不論是慢性疾病或嚴重的急性疾病，也很可能經歷**心理困擾**，並且有較高風險發展出「**心理健康**」問題。因此，「**心理健康**」工作者應能辨識及評估「**身體健康**」問題；而**基層醫療**及**一般衛生工作者**則應具備能力，辨識「**心理健康**」問題，並將其與身體疾病或治療所產生的症狀區分開來。

政策應要求「衛生」部門設立一支強而有力、專責「心理健康」的團隊，並建立與其他部門之間的協調機制。「**心理健康**」團隊需要**獲得充足且穩定的資金**，以支持「**心理健康**」服務及相關支援。此外，還需要***建立「跨部門」合作***，以處理「**心理健康**」的重要「**社會及結構性決定因素**」，同時認知到這些因素也會影響「**身體健康**」。

將「**心理健康**」整合至一般及專門的「**衛生**」服務中，與設立專責的「**心理健康**」單位同樣重要。例如，***「心理健康」應整合至***：

- 急診及緊急醫療服務；
- 兒童及孕產婦醫療照護；
- 老年醫療照護；
- 非傳染性疾病照護(例如癌症、心血管、呼吸系統及自體免疫疾病)；
- 傳染病照護(例如 HIV/AIDS、結核病、瘧疾及被忽視的熱帶疾病)；
- 緩和醫療；
- 性健康及生殖健康照護；
- 酒精及其他精神活性物質使用相關服務。

對於患有「**心理健康**」問題或「**心理社會障礙**」的人而言，確保其能夠獲得一般及專門「**衛生**」服務至關重要。

要***讓「心理健康」專業知識普遍涵蓋整個「衛生」服務體系***，就需要

對所有衛生工作者進行基本「**心理健康**」及「**幸福**」相關知識與技能的培訓。同樣重要的是，***工作者應採取「以人權為基礎、以個人為中心」的方法***，並處理**影響健康**的「**社會及結構性因素**」。如果某一「**衛生**」服務機構沒有直接聘用「**心理健康**」專業人員，則應建立機制，以便取得其專業支援。

有關「**心理健康**」政策及策略行動各方面的完整資訊，可參閱 **WHO**《心理健康政策與策略行動計畫指南》(Guidance on mental health policy and strategic action plans)的第 1–5 模組；而有關將「**心理健康**」條款納入法律，以及**人權**與**立法**方面的指南，可參閱 **WHO**《心理健康、國際人權與立法：指南與實務》(Mental health, human rights and legislation: guidance and practic)。

本《**指南**》認知到，「**心理健康政策**」通常屬於「**衛生**」部門的職責範圍，而「**衛生**」部門的許多核心活動本身已經有助於、或直接致力於保護及促進「**心理健康**」。然而，為確保「**心理健康**」能在一般衛生規劃、融資、服務發展及提供等各個領域獲得充分處理，《**指南**》提出了一系列可納入更廣泛「**衛生**」部門政策的「**心理健康政策指示與關鍵策略行動**」。

本《**指南**》使用 **H**(health，**衛生**)作為編號前綴，以避免在討論特定部門或其他《**指南**》中的政策指示時產生混淆。策略行動強調，***「心理健康」應被整合為「全民健康覆蓋」(Universal Health Coverage, UHC)的核心組成部分***，而且***每個人都應享有公平取得完整、高品質「心理健康」服務與支援的機會，不論其社會經濟地位或居住地為何***。

需要注意的是，本《**指南**》其他章節所涵蓋的許多議題，例如**社會保護、教育部門，以及都市與農村發展部門**，都與「**衛生**」部門**直接**或**間接**相關。

本《**指南**》也提供了可調整使用的策略行動指標範例，並**認知**到**監測與評估**在確保「**責信**」及推動**持續改善**方面所扮演的重要角色。清楚且可衡量的指標能讓各部門追蹤進展、評估影響，並判斷預期成果是否已經達成。至於與各部門工作及職責相關、更一般性的「**衛生**」**與公平指標**，請參閱 **WHO**《健康公平性社會決定因素監測的操作性框架》。

(二)文化、藝術與體育

「**文化、藝術與體育**」能*大幅促進更健康、更具包容性與公平性的「社區」*。這些領域應成為發展政策的核心，因為它們在實現《**永續發展目標**》(Sustainable Development Goals, SDGs)方面發揮重要作用。這些目標有助於讓「**城市**」與「**社區**」更加安全、更具韌性與永續性(SDG 11)，促進所有年齡層的健康與「**幸福**」(SDG 3)，減少不平等(SDG 10)，確保包容且優質的教育(SDG 4)，並建立更公正、和平的社會(SDG 16)。

除了廣泛的**社會效益**之外，「**文化、藝術與體育**」也對「**心理健康**」具有深遠影響。然而，儘管越來越多證據顯示這些領域有助於支持「**心理健康**」，但「**心理健康**」仍未被充分重視。*文化背景、地方脈絡與文化遺產價值會影響「社區」如何理解及回應「心理健康」議題*。參與「**藝術**」活動涵蓋多種正向的要素，包括情緒表達、認知刺激、社會互動等，並已知能增進「**心理健康**」與「**幸福**」。「**藝術**」也提供了處理與「**心理健康**」相關議題的機會，例如鼓勵對話與減少污名。另一方面，參與「**運動**」與「**身體活動**」可以降低壓力、改善「**身體健康**」與認知功能，並增強社會連結，這些都能對「**心理健康**」產生正面影響。然而，儘管全球已投入許多努力，仍有四分之一的成年人及四分之三的青少年未達到建議的「身體活動」量。

此《**指南**》強調「**心理健康**」與「**文化、藝術及體育**」部門之間的重要關聯，並認識到這些部門的許多活動本身已能保護並促進「**心理健康**」。此外，本《**指南**》提出一系列政策指導方針與策略行動，可整合至各部門政策之中，以同時支持改善「**心理健康**」成果與該部門更廣泛的目標。本文使用**CAS**(culture, arts and sport；**文化、藝術與體育**)作為前綴，以避免在討論特定部門或其他《**指南**》所涵蓋的部門時產生混淆。具體而言，本《**指南**》提供一套策略行動範例，說明如何透過文化遺產及以「文化」為基礎的方法，處理影響當地「**社區心理健康**」的問題。另一個重點是提供「**文化、藝術與體育**」活動，以促進地方「**社區**」及「**健康**」、「**心理健康**」與社會照護服務中的「**心理健康**」與「**幸福**」。應促進對「**心理健康**」狀況、心理社會障礙者以及其他面臨歧視群體的包容與不歧視。此外，建立指導方針與監測機制也十分重要，以消除有害的文化習俗，並預防體育領域中的騷擾與虐待；這些措施對保護及促進「**心理健康**」至關重要。

需要注意的是，各部門的角色與責任可能因國家而異，因此此《**指南**》所涵蓋的某些領域，在不同國家可能屬於其他部門的職責。例如，與「**文化、藝術及體育**」相關的議題，可能會依各國的脈絡與制度，分別由**教育**、**青年**、

旅遊或**文化遺產**等部門負責。反之，在某個國家被視為**文化遺產**的議題，在另一個國家可能被歸入「**藝術**」範疇。

此《**指南**》提供了可調整運用的**策略行動指標範例**，並認識到**監測**與**評估**在確保「**責信**」、推動**持續改善**方面所扮演的關鍵角色。清楚且可衡量的指標能協助各部門追蹤進展、評估影響，並判斷預期成果是否已經實現。至於與各部門工作及職責相關、較為一般性的健康與公平指標，請參閱 **WHO**《健康公平性社會決定因素監測的操作性框架》。

(三)教育

童年期、**青春期**與**成年早期**是發展**「社會與情緒」連結**、建立**人際關係**、學習**應對壓力**，以及為未來的**學業成功**與**就業機會**奠定基礎的重要時期。

這同樣是一個「**心理健康**」問題與**情緒危機**可能開始出現的時期。有大量證據顯示，***童年期的發展對「心理健康」結果具有關鍵影響***。如果**童年時期**曾經歷「**不利事件**」與壓力，日後出現「**心理健康**」問題的可能性會提高，而不利的**童年經驗**會顯著增加罹患「**心理健康**」疾病的風險。

兒童、**青少年**及**年輕人**花費大量時間在「**教育**」環境中，因此***「學校」可以在促進與保護學生「心理健康」，以及改善其整體健康、學習成果與社會成果方面，發揮重要作用***。

在全球各地，患有「**心理健康**」問題或「**心理社會障礙**」的兒童，在接受幼兒教育、普通教育及高等教育時，往往面臨重大「**障礙**」。這些「**障礙**」可能包括在國家法律及政策中缺乏對相關「**障礙**」的認定。人們也可能遭受排斥、歧視，以及「**教育**」環境中的「**人權**」受到侵犯。這種傷害可能表現為缺乏**包容性**、**可及性**，以及受到**歧視性**撤銷政策的影響。除此之外，**教師**的「**心理健康**」與心理社會「**幸福**」也可能受到影響，**教師**及**高等教育機構的教職員**罹患「**心理健康**」問題的可能性**高於一般人口**。

此《**指南**》強調，***「教育體系」迫切需要進行全系統性的改革，並採取「全校性」的做法***，以確保所有人都能享有**包容性**、**可及性**及**非歧視性**的「**教育**」，並促進整個「**教育**」環境中***每個人***的「**心理健康**」與「**幸福**」。它進一步指出，政策制定者需要針對「**教育**」領域制定政策方向，以及一套相關的策略性行動，以處理「**教育**」環境中影響「**心理健康**」與「**幸福**」的廣泛問題。其目的在於協助政策制定者制定符合自身情境的具體政策、策略及/或行動。「**策**

略性行動」包括建立支持性的環境、處理霸凌問題(包括網路霸凌)、處理自殺問題(包括特定高風險族群的死亡)、檢視風險評估與評量架構，以及促進社會支持網絡與人際連結。

此外，《**指南**》機構應與其他部門的「**利害關係人**」合作。這包括與「**心理健康**」及「**社會**」部門合作，建立與「**社區心理健康**」及「**心理社會服務**」的聯繫。這種跨部門合作可以直接支持學生、教師、教職員及照顧者的「**心理健康**」。本《**指南**》也探討「**教育**」部門如何與醫療機構及其他相關部門合作，特別是確保弱勢學生能獲得適當的「**心理健康**」照護，以及確保相關服務涵蓋醫療、社會照護、法律執行與「**教育**」等領域。

此《**指南**》強調「**心理健康**」與「**教育**」之間的重要關聯，指出「**教育**」部門所承擔的許多核心活動，都能對保護及促進「**心理健康**」作出貢獻。因此，「**教育**」部門若能在不同的部門之間採取協調一致的方式，就可能在某些國家承擔更大的責任。

例如，在某些國家，職業訓練可能歸屬於「**就業**」部門；相反地，在其他國家，與「**教育**」相關的領域可能由本《**指南**》所涵蓋的其他部門負責。

此《**指南**》也提供可調整的指標範例，供策略性行動使用，並認知到監測與評估在確保「**責信**」、推動持續改善方面所扮演的重要角色。這些清楚且可衡量的指標可協助追蹤進展、評估影響，並判斷預期成果是否已經達成。關於一般健康與公平性的更多指標，可參考與各部門工作及職責相關的 **WHO**《健康公平性社會決定因素監測的操作性框架》文件。

(四)就業

全球約有 ***60%的人口***從事「**工作**」，而*「工作」占據其一生約三分之一的時間*。「**工作**」環境可能同時帶來「**心理健康**」的保護因素與風險因素。當「**職場**」具包容性、能促進「**心理健康**」與「**幸福**」，並降低「**心理社會**」風險與工作壓力時，往往與較佳的「心理與身體健康」結果、較高的工作績效與生產力、較高的工作動機，以及較少的缺勤與同事間衝突相關。

然而，當「**工作**」環境及相關「**職業風險**」未受到適當管理時，可能對工作者的「**心理健康**」造成嚴重後果，導致痛苦、「**心理健康**」問題或「**心理社會障礙**」。這些挑戰不僅可能*降低企業的生產力*，也可能*影響國家的整體經濟表現*。「**職業風險**」包括「工作」本身的性質、職場文化，以及「工作」控

制程度、「工作」量、需求與社會支持等因素。*貧困、工作不穩定，以及缺乏社會保障，會進一步加劇這些風險*。長工時或不規律工時、不安全或不健康的「工作」環境、不穩定的合約、低薪與有限的社會保障，以及霸凌、歧視與職場剝削，都會增加情緒困擾及「**心理健康**」問題惡化的可能性。來自低收入、中等收入及高收入國家的證據均顯示，*「工作」不穩定、經濟不安全與「心理健康」結果之間存在密切關聯*，尤其*對年輕人而言更為明顯*；這凸顯出迫切需要制定能降低「**工作**」不穩定性並促進穩定的就業政策，以保障「**心理健康**」與「**幸福**」。

與「**心理健康**」相關的「**缺勤**」，以及生產力下降(即「**出勤不工作**」〔presenteeism〕)，會對企業與經濟造成巨大的成本。同時，儘管已有證據顯示，就業能改善「**心理健康**」，許多患有「**心理健康**」問題或「**心理社會障礙**」的人仍然被排除在**勞動市場**之外。**人工智慧**(AI)與**自動化**等新興趨勢也帶來新的排斥風險，因為技術變革可能**減少「工作」機會**，尤其可能影響那些原本就在**勞動市場**中處於**弱勢地位的人**。未來，包容性的「**就業政策**」將對於同時應對持續存在及新出現的排斥風險、保護「**心理健康**」與「**幸福**」而言至關重要。

雖然「**就業**」可以透過收入、社會連結及使命感等方式，為「**心理健康**」提供重要的「**保護因素**」，但並非每個人都能獲得這些好處。對於心理社會障礙者、老年人及其他邊緣化群體而言，「就業」機會可能受到限制，或其所能進入的「**就業**」途徑較為狹窄，並面臨更高的歧視風險。因此，與「**就業**」相關的措施、政策及法律，應在兼顧企業利益(例如降低缺勤率與提升生產力)的同時，也納入「**社會目標**」，包括維護工作權、促進包容性，並*確保"所有人"都能從有意義的「就業」中獲益*。

投資於「**職場的心理健康**」，不僅有益於個別工作者與雇主，也有助於國家經濟成長，並且是實現聯合國《永續發展目標》(SDG)**8**「尊嚴就業與經濟成長」(Decent Work and Economic Growth)的重要一環。

此《**指南**》強調「**心理健康**」與「**就業**」部門之間的重要關聯，指出許多核心活動本身已能保護並促進「**心理健康**」。此外，本《**指南**》提出一系列可整合至各部門政策中的政策指令與策略行動，以支持改善「**心理健康**」成果，以及實現更廣泛的「**就業**」部門目標。為避免在討論特定部門或其他指南所提出的政策指令時產生混淆，本《**指南**》使用 **Em**(employment，就業)作為前綴。

具體而言，此《**指南**》建議採取策略性行動，重點包括：**促進具包容性且不具歧視性的職場**；**確保公平且體面的「工作」條件與社會保障**；以及***將「心理健康」與「身體健康」置於同等地位***，**納入職業安全與健康相關法律、法規及制度之中**。此外，本《**指南**》也提出「**預防**」及管理「**心理社會風險**」的策略性行動，包括**改善工作組織、工作設計與工作場所實務**；**建立正向的工作環境與文化**；以及**提升管理者與工作者的能力**，以支持「**心理健康**」。最後，本《**指南**》探討如何促進早期求助、支持康復與重返工作，以及確保工作場所與社區服務中，都能公平地取得**以權利為基礎**的「**心理健康**」與**心理社會支持**。

需要注意的是，各部門的角色與責任可能因國家而異，因此，本《**指南**》所涵蓋的部分領域，在不同國家可能屬於其他部門的職責。例如，與「**就業**」相關的措施可能由**司法**或**衛生**部門負責，具體取決於各國的制度與架構。反之，一些被視為法律事務的議題，也可能在本《**指南**》的「**就業**」範疇下進行討論。

此《**指南**》提供可調整使用的「**策略行動指標**」範例，並**認識**到**監測**與**評估**對於確保「**責信**」以及推動**持續改善**所發揮的關鍵作用。清楚且可衡量的指標能讓各部門追蹤進展、評估影響，並判斷預期成果是否已經達成。如需更多與各部門工作及職責相關的健康與公平指標，請參閱 **WHO**《健康公平性社會決定因素監測的操作性框架》。

(五)環境、保育與氣候保護

「**氣候變遷**」與**環境破壞**是嚴重的全球性威脅，影響所有人，並對人們的「**身心健康**」造成**直接**與**間接**的影響。人們經歷**颶風**、**洪水**、**山崩**、**乾旱**與**野火**等「**自然災害**」所造成的環境災難，或目睹森林砍伐、工業排放以及自然資源過度開發等人類活動造成的環境破壞，都可能導致**情緒困擾**增加與**壓力反應**加劇，甚至造成或加重憂鬱、焦慮及其他「**心理健康**」問題。然而，這些影響並非由所有人平均承受。環境破壞與「**氣候變遷**」對原本就**面臨歧視風險的族群**造成不成比例的影響，包括**低收入社區**、**原住民族**、**少數族裔**，以及**身心障礙者**。

其他「**環境因素**」也會損害「**心理健康**」。**空氣**、**噪音**與**光線污染**，皆與較高的憂鬱、壓力、睡眠問題、注意力不集中、疲勞及易怒風險有關。**水資源不足**與**衛生條件不完善**，包括缺乏乾淨飲用水、衛生設施以及適當的廢棄物

處理，已被廣泛證實會損害「**心理健康**」，導致更高程度的壓力、憂鬱與焦慮。這個問題影響*全球數百萬人*，尤其是低收入社區、非正式聚落，以及無法取得水、衛生設施與個人衛生(WASH)服務的貧民窟。

「**氣候變遷**」的長期影響，例如糧食與水資源短缺、經濟不穩定、武裝衝突，以及氣候所導致的流離失所與人口遷移，進一步增加情緒困擾以及「**心理健康**」問題發生或惡化的風險。

此《**指南**》強調「**心理健康**」與「**環境、自然保育及氣候保護**」之間的重要關聯，並指出許多「**衛生**」部門已採取的行動，其實也有助於保護及促進「**心理健康**」。此外，本《**指南**》提出一系列政策方向與策略性行動，可整合至不同部門的政策中，以支持改善「**心理健康**」成果及該領域更廣泛的目標。本《**指南**》的編號採用 **ECC(環境、自然保育與氣候保護)**前綴，以避免在討論特定部門或其他指引中的政策方向時產生混淆。特別是，本《**指南**》針對「**環境、自然保育與氣候保護**」部門，提出國家及區域層級的策略性行動，重點包括：**將「心理健康」納入領導與政策工作**；採取同時保護環境並促進「**心理健康**」與「**幸福**」的措施；以及促進「**心理健康**」專業人員與地方「**社區**」之間的合作，以因應環境破壞與「**氣候變遷**」對「**心理健康**」的影響。

鑑於「**心理健康**」與「**環境條件**」之間存在密切關聯，「**環境、自然保育、氣候保護**」與「**心理健康**」部門之間的合作，對有效落實相關策略至關重要。跨部門合作對於實現以下目標也十分重要：**打造更安全、更具韌性及永續的城市**(SDG 11)；**提供可負擔且潔淨的能源**(SDG 7)以及**潔淨的水與衛生設施**(SDG 6)；並**採取積極行動應對氣候變遷及其影響**(SDG 13、15)。***良好的「心理健康」也有助於實現更廣泛的《永續發展目標》***，這些目標與「**環境、自然保育及氣候保護**」部門息息相關，包括**支持負責任的消費與生產**(SDG 12)、**協助消除貧窮**(SDG 1)，以及**推動減少不平等的進展**(SDG 10)。

需要注意的是，各部門的角色與責任可能因國家而異，此《**指南**》所涵蓋的領域有時也可能屬於其他部門的職責。例如，在某些國家，與「**環境、自然保育及氣候保護**」相關的議題可能由**自然資源**、**農業**、**基礎建設**、**能源**或「**都市發展**」等部門負責，具體取決於各國的制度與組織架構。反之，在某些國家被視為「**都市發展**」規劃的議題，也可能在本《**指南**》中歸入「**環境、自然保育及氣候保護**」的範疇。

此《**指南**》提供可調整運用的策略性行動指標範例，並認知到監測與評

估在確保「**責信**」及推動持續改善方面所扮演的重要角色。明確且可衡量的指標能讓各部門追蹤進展、評估影響，並判斷預期成果是否已經實現。如需更多與各部門工作及職責相關的健康與公平指標，請參閱 **WHO**《健康公平性社會決定因素監測的操作性框架》。

(六)國防與退伍軍人事務

在**世界各地**，目前有***超過 2,700 萬人***正在各國的武裝部隊中服役。曾經服過役的人也占相當大的比例，並且代表了社會中的重要人口群體。在美國，僅「**退伍軍人**」就超過 **1,800 萬人**，約**占成年人口的 7%**。 鑑於這些數據，「**國防**」政策與行動，以及「**退伍軍人**」部門，可以對相當大一部分人口的「**健康**」與「**幸福**」產生影響。如果能全面且有效地落實這些政策與行動，將能顯著改善「**現役軍人**」與「**退伍軍人**」的「**心理健康**」及整體「**幸福**」。

軍事環境是一種獨特的工作環境，具有嚴格的規章制度、階級體系以及指揮鏈。**軍事人員**在執行任務與部署期間，會面臨各種「**艱困**」情境，包括**與家人分離**、**遭受艱苦環境**，以及**面臨死亡和嚴重受傷的風險**。這些專業上的挑戰與個人所經歷的「**創傷性事件**」，可能導致**情緒壓力**、**心理創傷**與**「心理健康」危機**，並可能促成**焦慮症**、**憂鬱症**、**創傷後壓力症候群**(PTSD)及**物質使用障礙**等「**心理健康**」問題。

「**國防與退伍軍人**」部門的政策與行動，可以建立**支持體系**，為軍人、退伍軍人及其家屬提供**可取得**、**高品質**且**以權利為基礎**的「**心理健康**」與「**心理社會支持**」。然而，要解決**軍事文化**中對尋求「**心理健康**」支持所造成的重大障礙至關重要。這些障礙包括普遍存在的**制度性污名與自我污名**、**對保密性的疑慮**，以及**擔心遭受歧視與騷擾**，包括性騷擾。

從「**現役軍人**」身分轉換至平民生活與職涯的「**退伍軍人**」，也會面臨適應新「**社區**」及在軍事環境之外建立生活的挑戰。**家庭狀況**、**轉換身分時的年齡**、**經濟不穩定**、**住房不安全**，以及**求職**、**教育**或**重新接受職業訓練**方面的困難，都可能影響「**心理健康**」。此外，在平民社會中找不到人生目標、尊重與認同，也可能成為一項挑戰。

此《**指南**》強調「**心理健康**」與「**國防及退伍軍人**」部門之間的重要關聯，並提出三項政策方向，以及一套相關的策略性行動。文件中使用「**DV**」

(國防與退伍軍人部門)這一術語，是為了避免在討論特定部門或其他《**指南**》中所提出的策略性行動時產生混淆。這些策略性行動可以整合至現有政策中，以支持改善「**心理健康**」成果及該部門更廣泛的目標。尤其是，落實這些策略性行動有助於預防騷擾與暴力、消除污名與歧視，並確保退伍軍人及其家屬能獲得**社會福利**與**社區支持**。

本部門《**指南**》所涵蓋的部分領域，在某些國家可能屬於不同部門的職責。例如，有些國家設有專責的**退伍軍人事務部**，而另一些國家則由**社會保護**或**衛生部門**負責「**退伍軍人**」相關事務。相反地，與「**國防及退伍軍人**」相關的領域，也可能在其他國家的《**指南**》中有所涵蓋。

此《**指南**》包含可調整運用的指標範例，作為**策略性行動**的一部分，並認識到**監測**與**評估**對確保「**責信**」及推動**持續改善**具有關鍵作用。清楚且可衡量的指標有助於追蹤進展、評估影響，並判斷預期成果是否已達成。若要了解與各部門工作及職責相關的更一般性健康與公平指標，請參閱 **WHO**《健康公平性社會決定因素監測的操作性框架》。

(七)內政

「**內政**」部門負責**內政事務**、**警政**、**緊急應變**與**公共安全**，對**人口**的「**心理健康**」具有重大影響。該部門需要應對各種「**緊急事件**」，包括**洪水**、**地震**或**健康緊急事件**等「**自然災害**」，以及**大規模槍擊**、**恐怖攻擊**和**個人危機**等「**人為事件**」。所有這些「**緊急事件**」都可能對「**心理健康**」與「**幸福**」造成深遠影響。作為與「**衛生**」部門及其他部門的重要合作夥伴，以及**人道援助機構**，***「內政」部門在將「心理健康」與「心理社會支持」納入防災準備、應變及復原工作方面扮演關鍵角色***，以確保第一線應變人員具備適當的應對能力。由於「**內政**」部門的重要職責，當有人正在經歷「**心理健康**」危機時，**警察**與**緊急應變人員**往往是最先前往協助的人員。然而，***這些情況並不總是能夠順利處理，許多事件最終導致非自願治療、暴力、虐待，甚至死亡，凸顯出迫切需要進行改變***。

「**內政**」部門的職責範圍廣泛，也在支援難民、庇護申請者及移民方面發揮重要作用。「**內政**」部門經常負責處理涉及**大量人口的跨部門應變**，例如大規模移民抵達、海上抵達者，以及處理處境極為脆弱人士的需求，包括無人陪伴的未成年兒童、人口販運受害者或身分不合法者。「**內政**」部門也會在較為

例行的行政及登記程序中與移民接觸。

許多移民享有良好的生活條件、公平的工作環境及獲得權利的機會。然而，隨著全球移民人口持續增加，某些群體——例如處於不穩定、低技能、非正規或半正規就業狀態的人——面臨更高的剝削、歧視及獲取服務受限的風險。許多人還面臨語言障礙、社會孤立及生活條件不佳等問題。所有這些因素都可能嚴重影響「**心理健康**」，增加情緒困擾的可能性。因此，投資於移民、難民及庇護申請者的「**心理健康**」措施，對於有效的移民治理以及實現 **SDG 10**(減少不平等)而言至關重要。事實上，正如 **SDG 16**(促進和平、正義及健全制度)所要求的，「**內政**」部門在其眾多職責中所做的努力，對於促進和平、推動永續發展，以及建立有效、負責且具包容性的制度至關重要。

本《**指南**》指出「**心理健康**」與「**內政**」部門之間的重要關聯，並認識到該部門的許多核心活動本身就有助於保護及促進「**心理健康**」。此外，本《**指南**》提出一套政策指令及策略行動，以便將其納入「**內政**」政策，從而同時支持改善「**心理健康**」成果以及實現「**內政**」部門更廣泛的目標。

需要注意的是，各國的部門職責與責任可能有所不同，因此本《**指南**》中所涵蓋的部分領域，在某些國家可能完全屬於不同部門的職責。例如，在一些國家，內政事務、警政、緊急應變及公共安全可能歸「**司法**」部門負責，或者由「**司法**」與「**內政**」部門共同負責。反之，與「**內政**」部門相關的議題，在其他國家則可能由不同部門負責。

本《**指南**》提供了可依不同情況調整的「**策略行動指標**」範例，並認識到監測與評估在確保「**責信**」以及推動持續改善方面所扮演的關鍵角色。清楚且可衡量的指標，使各部門能夠追蹤進展、評估影響，並判斷預期成果是否已經實現。若要查閱與各部門工作及職責相關、更一般性的「**健康與公平**」指標，請參閱 **WHO**《健康公平性社會決定因素監測的操作性框架》。

(八)「司法」

「**司法**」部門負責立法、法律改革、法院(司法機關)以及更廣泛的「**刑事司法體系**」，對*每個人*的「**心理健康**」都有直接和間接的影響，包括一般大眾、犯罪受害者、證人、被指控者及已定罪的犯罪者等。

「**司法**」部門的政策與立法會在不同層面產生影響。例如，以廣泛人權為基礎的法律與政策改革、反歧視、司法近用、承認法律能力、將自殺除罪

化，以及提供適當的服務與支持，都能在整體上促進「**心理健康**」，同時保障「**心理健康**」問題或「**心理社會障礙者**」的權利。

此外，處理關鍵議題的「**心理健康**」相關立法，例如承認並支持替代決策，以及消除強制措施，也有助於使一個國家的「**心理健康**」與社會照護體系符合包括《**身心障礙者權利公約**》(CRPD)在內的國際「**人權**」文書，並有助於減少不平等(SDG 10)及促進公正與和平的社會(SDG 16)。

「**刑事司法體系**」對「**心理健康**」具有重大影響，也為許多國家帶來沉重的社會與經濟負擔。它不僅影響被拘留者本身的「**心理健康**」結果，也影響其家人，尤其是子女。

在多數國家，「**心理健康**」問題或「**心理社會障礙者**」在審前拘留場所、監獄(用於較長期的拘禁)以及少年拘留設施中的比例明顯偏高。例如，一項針對 **43 個國家**的研究發現，***監獄人口中的憂鬱症合併盛行率為 12.8%***，而精神疾病的比例為 **4.1%**。***「被拘留」本身就是經歷「心理健康」危機及發展「心理健康」問題的重要風險因素***。在審判前及審判後推動自願性的分流措施，以及採取替代拘禁的措施(例如教育或針對輕微違法行為的支持計畫)，有助於減輕「**刑事司法體系**」整體造成的「**心理健康**」負擔。

遭到「**拘留或監禁**」的人往往無法獲得高品質的「**心理健康**」及「**心理社會**」服務，這些服務對滿足其需求及支持其康復相當重要。***這些人中的大多數最終都會回到「社區」***；如果他們在未接受治療或「**心理健康**」狀況惡化的情況下獲釋，不僅會損害其自身「**幸福**」，也會對整個社會造成負面影響。透過「**司法**」部門、「**司法**」工作者及其他相關人員之間的合作，可以制定並實施相關措施，為已有「**心理健康**」問題的被拘留者提供治療，並保護及促進被拘留者及拘留中心工作人員的「**心理健康**」。這包括確保監獄及其他拘留設施提供高品質、**以權利為基礎**的「**心理健康**」及「**心理社會**」服務。

在一些國家，「**心理健康**」問題者可能在法醫精神科設施中遭到無限期拘留，而沒有被定罪或沒有具體期限的刑期。惡劣的身體環境、有限的社交互動，以及缺乏休閒活動，都會進一步損害被拘留者以及在這些環境中工作的員工的「**心理健康**」。

「**司法**」部門也負有確保「**心理健康**」問題或「**心理社會障礙**」的犯罪受害者或法律程序中的證人能夠「**平等近用司法**」的責任。在許多「**司法**」管轄區，他們面臨歧視以及限制其充分參與司法程序的程序性障礙。例如，他們

可能被排除在作證之外、被認為不可信，或被拒絕提供必要的合理調整與支持。

「**司法**」部門的責任還包括確保在「**心理健康**」環境中遭受暴力或虐待的人，與其他人一樣享有獲得承認與支持、平等取得「**司法**」及法律資源的權利。然而，投訴經常未被調查、僅依賴工作人員的證詞而遭駁回，且沒有被正式記錄。因此，「**心理健康**」問題者往往無法獲得應有的補救、賠償以及其他人所能取得的支持服務。

「**司法**」部門的行動同樣對滿足接觸「司法體系」的**兒童與青少年**的特殊需求至關重要，無論他們是受害者、證人還是被指控者。這包括確保相關程序對兒童及青少年而言容易理解且適當、優先採用非拘禁性處分，並在無法避免拘禁時提供符合年齡需求的保障與支持。

本《**指南**》強調「**心理健康**」與「**司法**」部門之間的重要聯繫，並提出一系列可整合至部門政策中的政策指令與策略行動，以同時改善「**心理健康**」結果及實現「**司法**」部門的更廣泛目標。編號使用前綴「**justice**」**(司法)**，以避免在討論特定部門或其他《**指南**》中的政策指令時產生混淆。具體而言，本《**指南**》建議採取以下行動：

- 改善司法及人權的近用；
- 建立監測及處理人權侵害的機制；
- 保護司法工作人員及監獄內人員的心理健康；
- 確保在整個司法程序中提供以權利為基礎、高品質的心理健康服務；
- 協助離開拘留所、監獄及法醫精神科設施的人重新融入社區。

需要注意的是，各國不同部門的角色與責任有所不同，本《**指南**》所涵蓋的部分領域可能有時屬於其他部門的職責。例如，在某些國家，監獄屬於「**內政**」部門的責任；而在其他國家，則屬於「**司法**」部門的責任，或由兩個部門共同負責。反過來，有些國家認為屬於「**司法**」部門的議題，可能會在本《**指南**》的其他部分中討論。

此《**指南**》提供了可調整運用的「**策略行動指標**」範例，並強調監測與評估在確保「**責信**」以及推動持續改善方面的重要作用。清楚且可衡量的指標能讓各部門追蹤進展、評估影響，並判斷預期成果是否正在實現。至於與各部

門工作及職責相關、更一般性的「**健康與公平**」指標，請參閱 **WHO**《健康公平性社會決定因素監測的操作性框架》。

(九)社會保障

全民「社會保障」以及享有「社會安全」的權利，均已納入《永續發展目標》，目標是*在 2030 年前實現*。這些也是許多國家議程中促進人類發展、經濟成長及社會凝聚力的重要元素。這些要素對發展政策至關重要，在消除貧窮與飢餓(SDG 1 和 SDG 2)、促進全民健康生活與幸福(SDG 3)、實現性別平等(SDG 5)、減少不平等(SDG 10)，以及促進公正與和平社會(SDG 16)方面，都扮演著重要角色。

儘管已取得重大進展，全球仍有許多人無法獲得充分的「**社會保障**」，這種差距在低收入國家以及面臨歧視的群體中尤其明顯，其中包括具有「**心理健康**」問題或「**心理社會障礙**」的人士。例如，在高收入國家，超過一半的失業勞工可以領取失業給付；相較之下，低收入國家僅有 1%的失業勞工能獲得相關給付。同樣地，在高收入國家，63%被認為處於弱勢或面臨歧視風險的人口能獲得現金給付，而低收入國家僅有 7.8%。

有限或不存在的「**社會保障**」，使人們——尤其是面臨歧視的群體——更容易陷入貧窮、不平等、健康問題及社會排除。上述困境都與「**心理健康**」和「**幸福**」不佳密切相關。例如，貧窮與所面臨的各種挑戰，例如住房不穩定、營養不足以及資源取得受限，都會增加罹患「**心理健康**」問題的風險。收入不穩定與失業本身也會導致心理壓力增加及「**心理健康**」惡化。此外，基於年齡、性別、性別認同、性傾向、身心障礙狀況、移民或難民身分、種族或族群、原住民族身分，或無家可歸等特徵所造成的不平等，可能導致「**心理健康**」問題及社會排除，並進一步加劇既有的「**心理健康**」狀況。

在人的一生中持續投資於「社會保障」，並確保人們在生命中的脆弱時期——包括面臨經濟困難的期間——獲得支持，對「**心理健康**」至關重要。這不僅能改善生活水準，也能透過降低與貧窮、社會排除、經濟不穩定、失業及社會不平等相關的壓力與焦慮，對「**心理健康**」產生深遠影響。有效的「**社會保障**」能透過提供穩定與支持，從幼兒期一直到老年期提升整體「**幸福**」，而這些因素對早期心理「**韌性**」的培養至關重要。此外，「**心理健康**」也能透過提高生產力與就業能力、增加家庭收入，以及促進消費與支出，來支持經濟發

展。這些經濟改善反過來又能透過減輕經濟壓力，進一步改善「**心理健康**」結果。

本《**指南**》強調「**心理健康**」與「**社會保障**」之間的重要關聯，並指出該部門許多核心活動本身就有助於保護及促進「**心理健康**」。此外，本《**指南**》提出一系列政策指導方針與策略行動，可整合至「**社會保障**」政策中，以同時改善「**心理健康**」成果及該部門更廣泛的目標。為避免在討論特定部門的政策指導方針或其他指引時產生混淆，本《**指南**》使用 **SP**(social protection，**社會保障**) 作為編號前綴。本《**指南**》特別概述了有助於「**心理健康**」的「**社會保障**」部門策略行動，包括針對面臨歧視群體的措施。這些策略行動著重於促進平等機會、社會包容與凝聚力、減少貧窮、處理失業問題、確保最低收入與退休金給付，以及確保人們能獲得高品質的社會照護與支持。

值得注意的是，各部門的角色與責任可能因國家而異，因此，本《**指南**》所涵蓋的某些領域可能屬於其他部門的職責。例如，女性賦權、多元性與包容性、兒童與青少年，或家庭相關政策，可能由其他部門負責。反之，本《**指南**》其他部分所討論的議題，也可能與「**社會保障**」部門相關。

此《**指南**》提供可調整應用的「**策略行動指標**」範例，並認識到監測與評估在確保「**責信**」及推動持續改善方面所扮演的重要角色。清楚且可衡量的指標能讓各部門追蹤進展、評估影響，並確認預期成果是否已經達成。如需更多一般性的「**健康與公平**」指標，以及與各部門工作與責任相關的指標，請參閱 **WHO**《健康公平性社會決定因素監測的操作性框架》。

(十)城鄉發展

在編寫本《**指南**》時，全球已有*超過一半的人口*居住於「**城市**」地區，預計到 **2050 年**這一比例將*上升至 70%*。都市化、城市快速發展，以及許多鄉村地區轉型為「**城市**」地區，都可能透過創造更多就業、教育及改善生活品質的機會，促進經濟成長並降低貧困與不平等。然而，如果都市化管理不當，快速的「**城市**」成長可能導致重大挑戰，包括環境損害、高度污染、犯罪增加、社會與經濟不平等，以及社會排除；這些問題都會損害人口的「**心理健康**」與「**幸福**」。

廣泛的不平等同時存在於「**城市內部**」以及「**城市與鄉村地區之間**」。

許多研究發現，生活在「**城市**」地區的人通常能夠獲得較好的醫療照護，且*整體「健康」結果往往優於「鄉村」地區居民*。然而，「**城市**」生活也可能與某些「**心理健康**」問題的風險增加有關。這些差異凸顯了不同居住環境之間存在的重大「**健康不平等**」。

儘管如此，居住在「**貧困城市**」地區的人，尤其是居住於**非正式聚落**或**貧民窟**的人，往往難以獲得基本服務、優質住房、就業與教育機會、健康食品、乾淨用水及衛生設施。對於較貧困的城市社區而言，即使城市中有更多自然空間，居民獲得這些空間的機會也往往受到限制；即使富裕鄰里擁有更多自然空間，情況亦可能如此。這種資源取得不足，會導致較差的「**身體與心理健康**」結果，即使這些人居住在「**城市**」地區。

相較於「**城市**」貧困地區所面臨的挑戰，居住在「**鄉村**」及**偏遠**地區的人，則面臨不同的「**心理健康**」照護障礙。這些障礙包括醫療服務可取得性有限、缺乏可負擔且便利的交通，以及高度的社會污名。這些**不平等現象**使這些「**社區**」中需要「**心理健康**」照護的人，往往面臨較差的「**健康**」結果。

政策與策略行動應優先致力於建立「*永續、包容且有益心理健康的城市與人類聚落*」，*讓所有人都能公平取得基本服務*。這些措施應包括**一般醫療**與「**心理健康**」服務及支持、優質教育、可負擔且安全的住房、有效且便利的交通、營養食品，以及自然空間。另一方面，政策與策略行動也應努力降低有害「**健康**」的因素，例如**空氣**、**噪音及光線污染**、**缺乏安全保障**、**住房不安全**，以及**交通系統不足**。

因此，*「城鄉發展」政策在塑造影響「健康」之「結構性與社會決定因素」的環境方面，扮演關鍵角色*。本《**指南**》強調了這些重要連結，並認知到該部門的許多核心活動本身就已經有助於保護與促進「**心理健康**」。

本《**指南**》所列的政策指示與策略行動，與**聯合國**《**永續發展目標**》一致，尤其是「**SDG 11：永續城市與社區**」。該目標旨在因應快速都市化所帶來的挑戰，並致力於使城市與人類聚落具備包容性、安全性、韌性及永續性。《**指南**》中的編號使用 **UR**(urban and rural，**都市與鄉村**)作為前綴，以避免在討論特定部門或其他《**指南**》中的政策指示時產生混淆。

策略行動可以整合至各部門的政策之中，同時支持改善「**心理健康**」結果，以及「**城鄉發展**」的更廣泛目標。具體而言，本《**指南**》提供了建立「**永續、包容且有益心理健康的城市與人類聚落**」之策略行動，並特別強調住房、

安全且具包容性的都市與農村環境，以及服務取得、「**心理健康意識**」與整體社會包容性。這些策略的實施將有助於實現 **SDG 11** 的目標，同時也能促進其他目標，例如**健康**(SDG 3)、**消除貧窮**(SDG 1)及整體「**幸福**」。

需要注意的是，各部門的角色與責任可能因國家而異，而且本《**指南**》中所涵蓋的某些議題，有時可能屬於其他部門的職責。例如，住房相關議題可能由專門的住房部門負責，也可能由多個部門共同整合處理。反之，本《**指南**》其他部分所討論的議題，也可能與「**城鄉發展**」部門相關。

此《**指南**》也提供了可調整的策略行動指標範例，並**認知**到**監測與評估**在確保「**責信**」及推動**持續改善**方面所扮演的重要角色。清楚且可衡量的指標能讓各部門追蹤進展、評估影響，並判斷預期成果是否已經達成。至於與各部門工作及職責相關、更一般性的「**健康與公平**」指標，則可參考 **WHO**《健康公平性社會決定因素監測的操作性框架》。

四、總結



世界衛生組織(WHO)於 **2025 年**發布此《保護及促進政府各部門心理健康與幸福的政策與策略行動指引》，是推動「**心理健康融入所有政策**」(MHiAP)的重要發展。這份《**指南**》最大的政策意義，在於***將「心理健康」從傳統上以「衛生」與「醫療」部門為主的議題，進一步提升為「政府整體治理與社會發展的共同責任」***。**WHO** 強調，「**心理健康**」不僅受到醫療服務影響，也深受教育、就業、住房、社會保障、司法、環境、城鄉發展、文化與體育等政策所形塑。因此，***各政府部門在制定政策、策略與計畫時，都應主動納入「心理健康」與「幸福」的考量***。

這份《**指南**》的核心精神是***從「治療疾病」進一步轉向「創造有利於心理健康的社會環境」***。**WHO** 認為，貧窮、失業、工作不穩定、教育機會不足、住房不安全、社會排除、污名與歧視、暴力、孤獨、氣候變遷、自然災害及環境污染等「**結構性與社會決定因素**」，都可能直接或間接影響「**心理健**

康」。因此，*改善「全民心理健康」不能只依賴增加心理治療或精神醫療服務，更需要從社會與生活環境的根本因素著手*，降低「**心理健康**」風險、強化「保護因素」，並創造安全、包容、公平且能促進「**幸福**」的生活條件。

在治理模式上，**WHO** 特別強調「**全政府**」(whole-of-government)與「**全社會**」(whole-of-society)的整體性做法。也就是說，*「心理健康政策」不能由「衛生」部門單獨推動，而必須由各政府部門共同承擔*，並進一步結合公民社會、社區、專業人員、學術研究機構、非政府組織、家庭與照顧者，以及具有「**心理健康**」問題**親身經驗者**等不同「**利害關係人**」的力量。尤其是「**具有親身經驗者**」的參與，能讓政策更貼近實際需求，避免政策僅由政府或專業人員單方面決定，並有助於建立更具包容性、回應性與「人權」保障的政策。

在「**跨部門**」政策制定上，指引提出「**六項共同原則**」，包括**以「人權」為基礎**、**採取「生命歷程」觀點**、**回應心理健康的「結構性與社會決定因素」**、**確保具有實質意義的公眾與親身經驗者參與**、**消除污名與歧視**，以及**採取「以實證為基礎」的方法**。這些原則顯示，「**心理健康政策**」不應只關注個人的疾病或症狀，而應從整體生命歷程與社會環境出發，關注不同群體所面臨的不平等，並以科學證據、良好實務及成本效益作為政策決策的重要依據。

此外，**WHO** 也指出，***MHiAP 能否真正落實，取決於政治意願、利害關係人參與、財務資源與責信機制等基礎條件。政府高層必須提供持續且明確的政治支持，各部門也必須讓相關利害關係人參與政策制定、執行與評估***。同時，「**心理健康政策**」不能只有政策宣示，還需要同步進行預算規劃，確保有足夠且持續的資源支持。政策執行後則必須透過明確的目標、責任、時程及可衡量指標進行監測與評估，以確認政策是否產生預期效果，並根據實際結果持續修正。

在實務操作方面，**WHO** 將跨部門心理健康政策的推動整理為「**八個相互連結的流程**」，包括進行高層次政策對話、提高心理健康意識並轉變思維、檢視現有政策、建立跨部門起草團隊、修訂或制定政策與計畫、進行廣泛諮詢、執行政策，以及監測與評估成果。這套流程的意義在於，將「**心理健康融入所有政策**」從抽象理念轉化為可以實際操作的政策治理機制，而且並非一次性的工作，而是透過持續監測、評估與修正，形成循環改善的政策過程。

從「**各部門**」來看，這份《**指南**》進一步說明不同政策領域如何成為「**心理健康促進**」的重要場域。在教育方面，應建立安全、包容且不歧視的學

習環境，處理霸凌、網路霸凌及學生「**心理健康**」問題，同時支持教師與教育工作者的「**心理健康**」；在就業方面，則應建立公平、安全、穩定且具包容性的工作環境，降低工作壓力、霸凌、歧視與工作不安全所造成的「**心理健康**」風險。在社會保障方面，則應透過收入支持、失業保障、退休金及社會照護等措施，降低貧窮與經濟不安全對「**心理健康**」造成的壓力。

同樣地，環境與氣候政策也應納入「**心理健康**」考量，例如降低空氣、噪音及光線污染，並因應氣候變遷、自然災害與環境破壞所造成的心理健康影響；城鄉發展則應透過安全且可負擔的住房、便利交通、基本服務、自然空間及包容性的城市規劃，建立有利「**心理健康**」的生活環境。司法部門則應保障心理健康問題者的人權與司法近用，減少不必要的拘禁，並提供適當的「**心理健康**」與心理社會支持；內政部門則應將「**心理健康**」納入災害應變、公共安全、警政及移民治理。文化、藝術與體育則可以透過藝術參與、身體活動、文化連結與社區參與，增進社會連結與幸福感。國防與退伍軍人政策則需要關注軍事人員、退伍軍人及其家庭所面臨的心理健康風險與社會適應問題。

因此，**WHO** 這份新《**指南**》所呈現的並不是單純增加「**心理健康**」服務的政策，而是一種「**政策思維與治理模式的轉變**」。其核心是認識到，*人民的「心理健康」與其所處的社會、經濟、教育、工作、家庭、環境及法律制度密切相關*；*如果政府只在心理疾病發生後提供治療，往往無法處理造成「心理健康不平等」的根本原因*。因此，政府應在政策形成的最前端就思考政策對「**心理健康**」的影響，並透過跨部門合作，降低風險因素、增加保護因素及改善健康公平。

總體而言，***MHiAP** 的核心就是將「心理健康」納入所有公共政策的決策過程，使每一項政策都能同時考量其對人民「心理健康」與「幸福」的影響*。這代表*「心理健康政策」的重點將由「疾病治療」逐漸擴展至「健康促進、疾病預防、社會公平、人權保障與環境改善」，並從單一部門的責任轉變為全政府及全社會共同承擔的責任*。其最終目標，是透過跨部門、以人權及實證為基礎的政策行動，建立一個更公平、包容、安全、永續且有利於「**全民心理健康與幸福**」的社會。